

令和8年6月施行

# 令和8年度 診療報酬改定

+3.09%改定の全体像と医科の主要変更点

---

厚生労働省保険局医療課 令和8年3月10日版資料に基づく

医知創造ラボ 今村久司

脳神経内科専門医

# 改定率の全体像 — +3.09%の内訳

## +3.09%

診療報酬本体  
(2年度平均)

R8年度

**+2.41%**

R9年度

**+3.77%**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 賃上げ分            | +1.70% |
| 物価対応分           | +0.76% |
| 食費・光熱水費         | +0.09% |
| R6改定以降 経営環境悪化対応 | +0.44% |
| 後発医薬品等 効率化      | ▲0.15% |
| その他             | +0.25% |

薬価等 薬価 ▲0.86% (R8年4月施行) + 材料 ▲0.01% = 合計 **▲0.87%**  
歯科**+0.31%** 調剤**+0.08%**

各科改定率 医科**+0.28%**

# 改定の4つの基本方針

1

物価・賃金・人手不足  
への対応

---

医療従事者の処遇改善  
ICT・AI・IoT活用  
タスク・シェアリング  
推進

2

2040年を見据えた  
機能分化・連携

---

「治す」と「治し、支  
える」  
かかりつけ医機能の評  
価  
外来の機能分化と連携

3

安心・安全で質の高い  
医療の推進

---

アウトカム評価の推進  
医療DX・ICT連携  
口腔管理のデジタル化

4

効率化・適正化

---

後発品の使用促進  
費用対効果評価の活用  
長期処方・リフィル推  
進

# 賃上げ対応 ― ベースアップ評価料の大幅見直し

## 賃上げ目標

R8年度 **+3.2%** R9年度 **+3.2%**

看護補助者・事務職員は **+5.7%**

## 対象の拡大

**事務職員** を新たに対象に追加

**保険薬局** も対象施設に追加

40歳以上の医師・歯科医師は除く

## 主な変更ポイント

- 1 R8年度とR9年度で段階的評価（R9年度は点数が倍増する設計）
- 2 継続的に賃上げを実施している施設と新規施設で異なる評価
- 3 入院BU評価料は165区分→250区分に拡大（R9年6月は500区分）
- 4 賃上げ未実施の医療機関には入院基本料の減算規定を新設

# 外来・在宅BU評価料（Ⅰ） — 具体的な点数変更

| 区分               | 現行  | R8 新規 | R8 継続 | R9 新規 | R9 継続 |
|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 初診時              | 6点  | 17点   | 23点   | 34点   | 40点   |
| 再診時              | 2点  | 4点    | 6点    | 8点    | 10点   |
| 訪問診療<br>(同一建物以外) | 28点 | 79点   | 107点  | 158点  | 186点  |
| 訪問診療<br>(同一訪問時)  | 7点  | 19点   | 26点   | 38点   | 45点   |

**注意：**賃上げ未実施の医療機関には入院基本料の減算規定を新設

例) 急性期一般入院料1の場合：1日あたり

**121点減算**

夜勤手当の増額にも使途拡大が可能に

# 物価対応 — 「物価対応料」の新設

R8年度以降の物価上昇に段階的に対応するため、初・再診料や入院料とは別に算定可能な加算として新設。R9年度は**R8年度の2倍**の点数となる。

## 外来・在宅物価対応料

|       | R8年度 | R9年度 |
|-------|------|------|
| 初診時   | 2点   | 4点   |
| 再診時等  | 2点   | 4点   |
| 訪問診療時 | 3点   | 6点   |

## 入院物価対応料（1日につき）

| 施設区分      | R8  | R9   |
|-----------|-----|------|
| 急性期病院A    | 66点 | 132点 |
| 急性期一般1    | 58点 | 116点 |
| 特定機能病院7:1 | 84点 | 168点 |
| 地域包括医療1   | 49点 | 98点  |
| 回復期リハ1    | 19点 | 38点  |
| 療養病棟1     | 18点 | 36点  |

# 入院基本料等の引き上げ — 主な点数変更

| 項目             | 現行     | 改定後           | 増点          |
|----------------|--------|---------------|-------------|
| 再診料            | 75点    | <b>76点</b>    | +1          |
| 急性期一般入院料1      | 1,688点 | <b>1,874点</b> | <b>+186</b> |
| 特定機能病院A 7:1    | 1,822点 | <b>2,146点</b> | <b>+324</b> |
| 地域包括医療病棟1      | 3,050点 | <b>3,367点</b> | <b>+317</b> |
| 回復期リハ病棟1       | 2,229点 | <b>2,346点</b> | <b>+117</b> |
| 療養病棟入院料1       | 1,964点 | <b>2,035点</b> | <b>+71</b>  |
| 精神病棟10:1       | 1,306点 | <b>1,471点</b> | <b>+165</b> |
| 地域包括ケア1(40日以内) | 2,838点 | <b>2,955点</b> | <b>+117</b> |

※初診料は291点で据置。初再診料が包括されるその他の入院料等についても同様に対応。

# 急性期病院の再編 — 急性期病院入院基本料の新設

「病棟単位」の評価から「**病院全体の急性期機能**」に着目した評価体系に転換

## 急性期病院A 一般入院料

**1,930点**

看護配置 7対1

### 要件（全て満たす）

- ・ 救急搬送 年間2,000件以上
- ・ 全身麻酔手術 年間1,200件以上
- ・ DPC対象病院
- ・ 地域包括医療病棟の届出なし

## 急性期病院B 一般入院料

**1,643点**

看護配置 10対1

### 要件（いずれか）

- ・ 救急搬送 1,500件以上
- ・ 救急搬送500件 + 全麻手術500件
- ・ 人口20万人未満の最大救急搬送病院
- ・ 離島地域の最大救急搬送病院

既存の急性期一般入院料1～6も引き続き選択可能 → **実績等に応じ医療機関が選択**

看護・多職種協働加算を新設：

**加算1 = 277点、加算2 = 255点**（PT/OT/ST/管理栄養士/臨検技師が病棟で協働）



# その他の重要変更

## 入院時の食費・光熱水費

食費基準額：690円 → **730円** (+40円/食)

光熱水費：398円 → **458円** (+60円/日)

患者負担：所得に応じ+20～40円/食

## 救命救急・ICUの見直し

救命救急入院料：4区分 → **2区分**

特定集中治療室管理料：6区分 →

**3区分**

SOFA患者割合：1割 →

**2割以上**

病院実績要件（搬送件数・手術件数）新設

## 特定機能病院入院基本料

**A・B・Cの3区分**に再編

A：幅広い診療科設置の特定機能病院

B：中長期目標を設定する特定機能病院

C：A・B以外の特定機能病院

## 重症度、医療・看護必要度

A・C項目に対象コード追加

該当患者割合に救急搬送応需係数を加味した**指数**に見直し

B項目測定：入院5日目以降 **7日ごとに1回でも可**

# Take Home Message

- 1 診療報酬本体 +3.09%（2年度平均）  
— 賃上げ+1.70%と物価対応+0.76%が二本柱
- 2 BU評価料が大幅拡充 — 事務職員を含む幅広い職員が対象  
賃上げ未実施には入院基本料の減算規定を新設
- 3 「物価対応料」を新設 — R9年度はR8年度の2倍  
入院基本料等も大幅増点（急性期一般1：+186点）
- 4 急性期病院A/B入院基本料を新設  
— 病院全体の急性期機能に着目した新評価体系
- 5 2年度同時改定の枠組み  
— R9年度に段階的引上げ、経済動向に応じた調整も